

Noções de Primeiros Socorros

EaD **SEST SENAT**





SEST – Serviço Social do Transporte

SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

Curso *on-line* – Noções de Primeiros Socorros –
Brasília: SEST/SENAT, 2016.

29 p. :il. – (EaD)

1. Primeiros socorros. 2. Acidente - prevenção. I.
Serviço Social do Transporte. II. Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte. III. Título.

CDU 614.88



ead.sestsenat.org.br

Sumário

Apresentação	4
Unidade 1 Atendimento Básico de Primeiros Socorros	5
1 A Importância de Prestar os Primeiros Socorros	6
2 Sinalização do Local de Acidente	8
3 Acionamento de Recursos: Bombeiros, Polícia, Ambulância e Outros	9
4 Verificação das Condições Gerais de Vítima de Acidente de Trânsito	10
Glossário	12
Atividades	13
Referências	15
Unidade 2 Procedimentos para o Atendimento das Vítimas	16
1 Casos de Hemorragia	17
2 Casos de Desmaio	18
3 Convulsões	19
4 Casos de Parada Cardiorrespiratória	20
5 Casos de Queimaduras	22
6 Casos de Fraturas	24
Glossário	25
Atividades	26
Referências	27
Gabarito	28

Apresentação

Prezado(a) aluno(a),

Seja bem-vindo(a) ao curso Noções de Primeiros Socorros!

Neste curso, você encontrará conceitos, situações extraídas do cotidiano e, ao final de cada unidade, atividades para a fixação do conteúdo. No decorrer dos seus estudos, você verá ícones que tem a finalidade de orientar seus estudos, estruturar o texto e ajudar na compreensão do conteúdo.

O curso possui carga horária total de 20 horas e foi organizado em 2 unidades, conforme a tabela a seguir.

Unidades	Carga Horária
Unidade 1 Atendimento Básico de Primeiros Socorros	10 horas
Unidade 2 Procedimentos para o Atendimento das Vítimas	10 horas

Fique atento! Para concluir o curso, você precisa:

- a) navegar por todos os conteúdos e realizar todas as atividades previstas nas “Aulas Interativas”;
- b) responder à “Avaliação final” e obter nota mínima igual ou superior a 60;
- c) responder à “Avaliação de Reação”; e
- d) acessar o “Ambiente do Aluno” e emitir o seu certificado.

Este curso é autoinstrucional, ou seja, sem acompanhamento de tutor. Em caso de dúvidas, entre em contato por e-mail no endereço eletrônico suporteead@sestsenat.org.br.

Bons estudos!

An abstract geometric pattern composed of numerous triangles in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The triangles are of different sizes and are arranged in a complex, overlapping manner, creating a mosaic-like effect. The pattern is more dense on the left side and becomes sparser towards the right.

UNIDADE 1 | ATENDIMENTO BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS

***EaD* SEST SENAT**

Unidade 1 | Atendimento Básico de Primeiros Socorros



Mesmo que você não seja o causador da situação, segundo o Artigo 135 do Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940), é crime deixar de pedir socorro ou de prestar assistência a pessoas em grave e **iminente** estado de perigo, nos casos em que essa atitude não lhe causa risco pessoal.

Em casos de acidente ou quando existe alguma pessoa se sentindo mal, o que se aconselha é, antes de tudo, chamar o Corpo de Bombeiros ou um socorro especializado. No entanto, há momentos em que o quadro da vítima pode piorar se ela não for socorrida imediatamente.

Quando nos vemos diante de um acidente, queremos logo ajudar a vítima. No entanto, se não estivermos preparados, há grandes chances de agravarmos a situação, causando lesões graves e definitivas.

Só podemos agir durante um socorro quando conhecemos as características do acidente. Um veículo acidentado, um local em chamas, vítimas presas nas ferragens, pessoa com algum mal súbito etc., são situações distintas, que devem ser consideradas na escolha da melhor forma do socorro das vítimas. Nesta unidade, vamos conhecer a importância da sinalização do local do acidente, saber acionar recursos, aprender a verificar as condições da vítima e conhecer os procedimentos corretos para prestar os primeiros socorros.

1 A Importância de Prestar os Primeiros Socorros

Primeiros socorros é o tipo de atendimento, temporário e imediato, prestado à vítima de acidente ou **mal súbito**, antes da chegada do socorro médico especializado. Sua finalidade é manter as **funções vitais** da vítima e evitar o agravamento da situação, até que a assistência médica e especializada possa chegar ao local. Esse atendimento pode proteger a pessoa contra maiores danos.



Durante o atendimento de primeiros socorros, é importante não causar o chamado segundo trauma, isto é, não ocasionar outras lesões ou agravar as lesões já existentes.

Antes de iniciar o atendimento, certifique-se de que existe segurança suficiente para você permanecer no local. Se você for prestar os primeiros socorros, a sequência das ações deve ser:

- 1) Manter a calma;
- 2) Garantir a sua segurança;
- 3) Sinalizar o local;
- 4) Solicitar socorro;
- 5) Verificar a situação das vítimas;
- 6) Realizar atendimento pré-hospitalar.

A seguir vamos detalhar os procedimentos básicos que devem ser adotados durante os primeiros socorros.



2 Sinalização do Local de Acidente

Após certificar-se de que é seguro permanecer na área, você deve isolar e sinalizar o local em que ocorreu o acidente ou a situação de emergência, não permitindo que pessoas ou veículos se aproximem.



A sinalização deve ser colocada sempre antes do local do acidente e deve ser visível. Não adianta colocar a indicação de maneira que as pessoas somente vão poder perceber ao chegar perto!

Muitos acidentes ocorrem nas vias públicas urbanas e rurais (ruas, avenidas, vielas, caminhos, estradas, rodovias etc.), impedindo ou dificultando a passagem normal dos outros veículos. Por isso, esteja certo de que situações de perigo vão ocorrer (novos acidentes ou atropelamentos), se você demorar muito ou não sinalizar o local de forma adequada.

Nos casos de acidentes na estrada, é preciso colocar o triângulo de segurança e, se estiverem disponíveis, os cones de sinalização, que devem ser posicionados a uma boa distância do veículo acidentado (se o acidente ocorrer na estrada, contar pelo menos 30 passos). Em vias com grande fluxo de veículos, é preciso alertar os motoristas antes que eles percebam o acidente. Dessa forma os outros motoristas poderão reduzir a velocidade, concentrar a atenção e desviar com segurança.

Não é só a sinalização que deve ser colocada antes do local do acidente. É necessário que todo o trecho, do início da sinalização até o acidente, seja demarcado, indicando o desvio de direção. Se isso não puder ser feito de forma completa, faça o melhor que puder, aguardando as equipes de socorro, que deverão completar a sinalização e os desvios.

Outro objetivo importante da sinalização é manter a fluidez do tráfego. Apesar do afunilamento provocado pelo acidente, deve sempre ser mantida uma via segura para os veículos passarem.



Você não é o responsável pela via, mas pode auxiliar em sua fluidez!

Faça isso por duas razões:

- Se ocorrer uma parada no tráfego, o congestionamento, ao surgir repentinamente, pode provocar novas colisões.
- Com o trânsito parado, as viaturas de socorro vão demorar mais a chegar.

3 Acionamento de Recursos: Bombeiros, Polícia, Ambulância e Outros

Em grande parte do Brasil, podemos contar com serviços de atendimento às emergências, que recebem chamados por telefone, fazem uma triagem prévia e enviam equipes treinadas e ambulâncias equipadas para o atendimento. Após uma primeira avaliação, os feridos são atendidos emergencialmente para, em seguida, serem transferidos aos hospitais.



Os atendimentos de emergência são serviços gratuitos, com números de telefone padronizados em todo o Brasil. Use um celular, os telefones dispostos nos acostamentos das rodovias, os telefones públicos ou peça para alguém que esteja passando para telefonar. Os telefones de emergência mais importantes são:

- 190 – Polícia Militar
- 191 – Polícia Rodoviária Federal (para acidentes em estradas e rodovias)
- 192 – SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

- 193 – Resgate do Corpo de Bombeiros
- 199 – Defesa Civil



Onde estiver disponível, o SAMU é o mais indicado para atender a maioria das vítimas de acidente de trânsito. Já o Corpo de Bombeiros deverá ser acionado quando outras circunstâncias se apresentarem, como, por exemplo, acidentes com alguma vítima presa na ferragem ou com riscos de incêndio.

Ao telefonar para pedir ajuda, para facilitar as providências de socorro, será necessário fornecer algumas informações:

- Local exato do acidente;
- O tipo de combustível ou produtos perigosos, caso existentes;
- Os veículos envolvidos;
- O número de vítimas; e
- Outros fatores agravantes.

4 Verificação das Condições Gerais de Vítima de Acidente de Trânsito

Ao iniciar contato com a vítima, preocupe-se inicialmente com os sinais vitais. Ao se aproximar e iniciar seu contato, a primeira coisa a ser observada é o nível de consciência. Adote o procedimento A.V.D.I.:

- A – Procure descobrir se a vítima está em ALERTA;
- V – Veja se ela responde ao estímulo VERBAL;
- D – Se ela não responder, efetue um estímulo DOLOROSO;

- I – Se não obtiver êxito, então a vítima deve estar INCONSCIENTE.

Em seguida você deve observar se a vítima está respirando.

Em vítimas de trauma, adotamos apenas a tração mandibular para verificar a respiração, sem mexer com o pescoço. Adote o ver, ouvir e sentir para certificar que a vítima está mesmo respirando.

Na sequência, verifique o pulso. Coloque os dedos indicador e anular, sobre o pulso e deslize para o lado. Verifique, também, se o cinto de segurança está dificultando a respiração da vítima. Neste caso, e somente neste caso, você deverá soltá-lo cuidadosamente, sem movimentar o corpo da vítima.

Segure a cabeça da vítima, pressionando a região das orelhas e impedindo a movimentação da cabeça. Se a vítima estiver de bruços ou de lado, procure alguém treinado para avaliar se ela necessita ser virada e como fazê-lo. Em geral ela só deverá ser virada se não estiver respirando. Se estiver de bruços e respirando, sustente cabeça nesta posição e aguarde o socorro chegar.



Terminada a verificação de sinais vitais, devemos nos preocupar em dar sequência ao atendimento, partindo para a avaliação secundária. Verificamos, nesse caso: objetos encravados, deslocamento de articulações, estados de choque, hemorragias, e monitoramento de sinais vitais

Resumindo

É importante estar preparado para prestar os primeiros socorros, pois se não estamos preparados, podemos agravar a situação, causando lesões graves e até mesmo definitivas.

A sinalização para indicar a ocorrência de um acidente deve ser colocada de maneira que as pessoas sejam avisadas antes de se aproximarem muito do local. Além disso, ela deve ser visível.

Após garantir a sua segurança, você poderá iniciar contato com a vítima preocupando-se inicialmente com os sinais vitais.

Glossário

Funções vitais: as funções exercidas pelo cérebro e pelo coração.

Iminente: que está quase a acontecer; imediato, próximo.

Mal súbito: pode ser definido como qualquer ocorrência repentina da perda da estabilidade hemodinâmica (circulação sanguínea) e/ou neurológica (cérebro) de um indivíduo.



Atividades

1) Onde estiver disponível, _____ é o mais indicado para atender a maioria das vítimas de acidente de trânsito, em especial dos acidentes que ocorrem na área urbana:

- a. () a Polícia Militar (PM)
- b. () o Resgate do Corpo de Bombeiros Militar (CBM)
- c. () a Polícia Rodoviária Federal (PRF)
- d. () o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

2) Primeiros socorros é o atendimento temporário e imediato, prestado à vítima de acidente ou mal súbito, antes da chegada do socorro especializado.

() Certo () Errado

3) O A.V.D.I. consiste em um procedimento cujo objetivo principal é o de verificar o nível de consciência da vítima. A sigla foi criada com base nos seguintes testes verificadores:

- a. () AÇÃO imediata; estímulo VERBAL; estímulo DOLOROSO; IMPROVISO
- b. () vítima ALERTA; estímulo VERBAL; estímulo DOLOROSO; vítima INCONSCIENTE
- c. () vítima ALERTA; VERIFICAÇÃO cardíaca; DOENTE crônico; vítima INCONSCIENTE
- d. () AÇÃO imediata; VERIFICAÇÃO cardíaca; estímulo DOLOROSO; vítima INCONSCIENTE

4) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso):

- a. () 190 é o número de telefone de emergência da Polícia Militar.
- b. () A primeira coisa a fazer em qualquer atendimento de emergência é testar o nível de consciência da vítima.
- c. () 193 é o número de telefone de emergência do Corpo de Bombeiros.
- d. () Após verificadas as condições da vítima você poderá chamar um socorro especializado.

Referências

ABRAMET. **Noções de primeiros socorros no trânsito**. São Paulo: Casa Brasileira do Livro, 2005.

APTOS CURSOS & SERVIÇOS. **Prevenção de Acidentes no Trânsito e Direção Defensiva** – Primeiros Socorros. Brasília, 2000.

BRASIL. **Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Rio de Janeiro, 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 24 out. 2015.

SILVA, A. K.; FERNANDES, A. **Tecnologia de Prevenção e Primeiros Socorros ao Trabalhador Acidentado**. São Paulo: AB, 2012.

VARELLA, D.; JARDIM, E. C. **Primeiros Socorros** – Um Guia Prático. São Paulo: Claro Enigma, 2011.

An abstract geometric pattern composed of numerous triangles in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The triangles are of different sizes and are arranged in a non-repeating, mosaic-like fashion, primarily concentrated in the lower half of the page.

UNIDADE 2 | PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO DAS VÍTIMAS

EaD SEST SENAT

Unidade 2 | Procedimentos para o Atendimento das Vítimas



Já sabemos que os primeiros socorros são importantíssimos para manter as funções vitais da vítima e evitar o agravamento da situação até que o socorro especializado chegue ao local. No entanto, após efetuar os primeiros socorros e verificar o estado das vítimas, é possível complementar o atendimento inicial com alguns cuidados que podem ser essenciais para reduzir os efeitos do acidente e os danos causados à saúde das vítimas.

Saber como agir em casos de vítimas com hemorragias pode ser um diferencial importante para evitar grande perda de sangue. Vítimas inconscientes ou em quadro de convulsão também podem ser atendidas com algumas dicas básicas. Além disso, se você se deparar com uma parada cardiorrespiratória, você saberá como retomar os batimentos cardíacos e a respiração da vítima?

Nesta unidade vamos conhecer alguns procedimentos básicos que vão além do atendimento inicial e que podem ajudar a salvar muitas vítimas ou garantir melhor recuperação das vítimas.

São necessários alguns cuidados básicos nas diversas situações de emergência, os quais podem variar de acordo com o estado das vítimas.

1 Casos de Hemorragia

São consequências de um rompimento, cisão ou dilaceração dos vasos sanguíneos, veias ou artérias, o que provoca a perda de sangue circulante para dentro ou para fora do corpo. As medidas a serem tomadas para reter uma hemorragia dependerão do local afetado.

A hemorragia pode ser interna ou externa e a gravidade é determinada pela duração e pela quantidade de sangue perdido.

- A hemorragia externa é o sangramento de estruturas superficiais e, normalmente, pode ser contida com compressão direta sobre o ferimento, com a elevação do membro afetado e por último, com a compressão de pontos arteriais.
- Já a hemorragia interna se caracteriza pela ruptura de vasos ou órgãos internos. Como o sangramento não pode ser visto, é necessário prestar muita atenção aos sinais e sintomas específicos da vítima e ter tempo de encaminhá-la ao socorro adequado.



Ao realizar os primeiros socorros, em caso de hemorragia, uma proteção para suas mãos é indispensável. Use luvas apropriadas e caso você apresente ferimentos, cubra seus próprios ferimentos para prevenir e evitar o contágio de doenças transmitidas pelo sangue, como AIDS, hepatite, entre outras.



2 Casos de Desmaio

Trata-se da perda repentina e temporária da consciência. Os desmaios são considerados uma forma leve de estado de choque, sendo, geralmente, provocados por emoções súbitas violentas, nervosismo intenso, pressão baixa ou fome (hipoglicemia), **reação vasovagal**, hipotensão postural etc.

O que fazer:

- Deitar a vítima para facilitar a circulação do sangue;
- Se possível, levantar suas pernas;
- Virar a cabeça da vítima para o lado a fim de evitar asfixia em caso de vômito e excesso de saliva;

- Se estiver consciente (ameaça de desmaio), sentar a vítima com os joelhos ligeiramente afastados e a cabeça entre eles, se possível abaixo deles;
- Quando a pessoa tiver recuperado a consciência, orientá-la para que respire profundamente e, ainda, para que force a elevação da cabeça, enquanto a pessoa que a socorre segura a cabeça dela pressionada levemente para baixo; e
- É necessário manter a vítima sentada e com a cabeça em nível baixo (entre os joelhos) ou mesmo deitada, pelo tempo necessário ao desaparecimento dos sintomas. Não deixe que fique em pé.

3 Convulsões

São contrações musculares generalizadas, violentas ou não, com possível perda da consciência. As causas são: febre muito alta, falta de oxigenação do cérebro e diversas doenças, como epilepsia, meningite e outras.

O que fazer:

- Proteger a vítima de objetos que possam machucá-la;
- Proteger a cabeça da vítima para que não bata no chão;
- Abrir vias aéreas proporcionando hiperextensão da **traqueia**;
- Deitar a vítima de lado para evitar a **broncoaspiração**.
- Verificar obstrução das **vias aéreas** (se há, na boca da vítima, chiclete, biscoito ou outro objeto que possa impedir a respiração);
- Não tentar controlar os movimentos convulsivos.

4 Casos de Parada Cardiorrespiratória

Se a vítima estiver respirando, significa que seu coração continua batendo, mesmo que não se consiga ouvir a sua pulsação. A reanimação deve ser aplicada somente quando ocorrer uma parada cardíaca, pois esta técnica pode interferir no ritmo do coração ou fazê-lo parar de vez.



A compressão faz com que o sangue saia do interior do coração, sendo lançado nas artérias, que vão nutrir os tecidos de oxigênio. Ao ser suspensa a pressão, o coração se enche de sangue novamente, proveniente das artérias, por sucção. Assista ao pequeno documentário do Corpo de Bombeiros a respeito desse assunto, acesse o link a seguir.

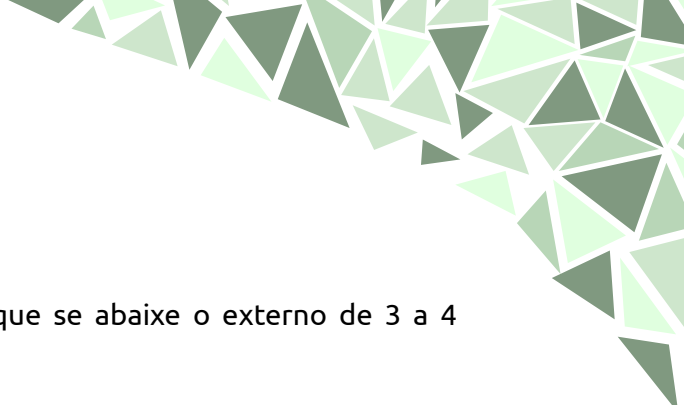
<http://corpodebombeiros.sp.gov.br/emb5/?p=2970>

a) Casos de Parada Cardíaca

Proceda da seguinte forma:

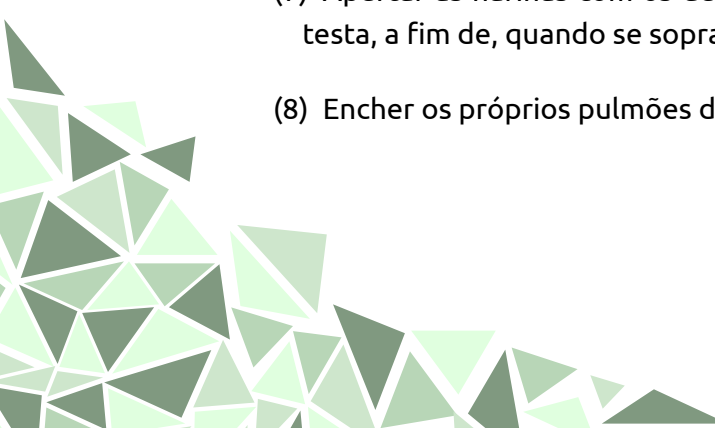
- (1) Acionar imediatamente a ambulância e o hospital. Nesses casos, realizar imediata massagem cardíaca, acompanhada de respiração boca-a-boca;
- (2) Colocar a vítima de costas sobre uma superfície dura e plana;
- (3) Colocar a sua mão sobre a parte inferior do esterno, e a outra sobre a primeira mão. Colocar apenas as palmas das mãos, sem que os dedos toquem o tórax;
- (4) Encolher os ombros;



- 
- (5) Aplicar pressão com bastante vigor, para que se abaixe o esterno de 3 a 4 centímetros;
 - (6) A seguir, soltar;
 - (7) Não alterar a posição das mãos;
 - (8) Repetir o movimento 60 vezes por minuto, ritmado com a mesma compressão;
 - (9) Para cada 15 compressões, aplicar 2 respirações boca-a-boca a cada intervalo (se houver 2 pessoas socorrendo, aplicar 1 respiração a cada 5 compressões);
 - (10) Sentir o pulso da vítima a cada 4 ciclos completos de compressões e respirações;
 - (11) Interromper a compressão do coração assim que puder sentir a pulsação da vítima; e
 - (12) Continuar a respiração boca-a-boca assim que a vítima volte a respirar.

b) Casos de Parada Respiratória

Realize os seguintes passos:

- (1) Acionar imediatamente a ambulância e o hospital;
 - (2) Iniciar prontamente a respiração de socorro pelo método boca-a-boca;
 - (3) Deitar a vítima de costas, com os braços estendidos ao longo do corpo;
 - (4) Afrouxar-lhe a roupa, deixando livre o tórax, o pescoço e o abdômen;
 - (5) Desobstruir as vias aéreas superiores (boca e garganta), retirando algum corpo estranho, dentadura, secreções e puxando a língua para a sua posição de descanso. Utilize para isto uma toalha ou par de luvas de látex existente na caixa de Primeiros Socorros;
 - (6) Suspender a cabeça da vítima pelo pescoço, com uma das mãos e com a outra mão na testa, inclinar bem a cabeça da vítima para trás;
 - (7) Apertar as narinas com os dedos (polegar e indicador) da mão que estiver na testa, a fim de, quando se soprar, evitar que o ar escape pelo nariz;
 - (8) Encher os próprios pulmões de ar;
- 

- (9) Cobrir a boca da vítima de forma a não deixar o ar escapar;
- (10) Soprar até ver o peito da vítima expandir. Se isto não ocorrer, ou se escutar algum ruído na garganta, pode haver algum corpo estranho preso. Retire-o com os dedos, colocando a vítima de lado ou de cabeça para baixo, dando leves palmadas nas costas;
- (11) Soltar o nariz e afastar sua boca da vítima, para permitir que o ar saia de seus pulmões;
- (12) Repetir o processo em torno de 16 vezes por minuto, até a vítima voltar a respirar espontaneamente e bem; e
- (13) Se necessário, trocar de pessoa, sem alterar o ritmo.



Dicas

Quando ocorre com a vítima, simultaneamente, parada cardíaca e respiratória, há necessidade de se fazer respiração artificial (boca a boca) e a massagem cardíaca ao mesmo tempo, o que conhecemos como Ressuscitação ou Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Se possível, aplique as técnicas de reanimação junto com outra pessoa.

5 Casos de Queimaduras

As queimaduras são classificadas em graus, e possuem os seguintes sintomas:

- (a) 1o Grau: lesão das camadas superficiais da pele; vermelhidão; dor local suportável; não há formação de bolhas.
- (b) 2o Grau: lesões das camadas profundas da pele; formação de bolhas; desprendimento de pele; dor e ardência; locais de intensidade variável.
- (c) 3o Grau: lesão de todas as camadas da pele; comprometimento dos tecidos mais profundos, até o osso.

Realize as seguintes ações:

- (1) Deitar a vítima;
- (2) Colocar algo sob os pés da vítima, de modo a manter o resto do corpo em posição mais baixa;
- (3) Lavar com água a área queimada;
- (4) Passar vaselina líquida esterilizada sobre a área queimada;
- (5) Cobrir a área queimada com gaze ou com a fralda de pano existente na caixa de primeiros socorros;
- (6) Se a vítima estiver consciente, dar-lhe bastante líquido para beber (de preferência água, mas nunca bebidas alcoólicas);
- (7) Colocar um pano limpo sobre a superfície queimada, enfaixando frouxamente.



Dicas No caso de queimaduras graves, acionar a ambulância e o hospital, e transportar a vítima o mais rapidamente possível

O que não fazer em caso de queimadura:

- Não passar pasta de dente, pomadas, ovo, manteiga, óleo de cozinha;
- Não passar gelo;
- Não furar as bolhas;
- Não retirar a pele morta;
- Não arrancar a roupa grudada na área queimada;
- Não apertar o ferimento.



A respeito de queimaduras, assista ao conselho do Dr. Dráuzio Varella acessando o link a seguir.

www.youtube.com/watch?v=xZu5cKpW_sl

6 Casos de Fraturas

A fratura é a quebra de um osso causada por uma pancada muito forte, uma queda ou esmagamento (por exemplo, devido à queda de uma carga ou uma colisão do veículo). Há dois tipos de fraturas: as fechadas, que, apesar do choque, deixam a pele intacta, e as expostas, quando o osso fere e atravessa a pele. As fraturas expostas exigem cuidados especiais, portanto, cubra o local com um pano limpo ou gaze e procure socorro imediato.

O que fazer:

- Não movimente a vítima até imobilizar o local atingido.
- Mantenha a pessoa calma e aquecida.
- Verifique se o ferimento não interrompeu a circulação sanguínea.
- Imobilize o osso ou articulação atingida com uma tala.
- Mantenha o local afetado em nível mais elevado que o resto do corpo e aplique compressas de gelo para diminuir o inchaço, a dor e a progressão do hematoma.

Resumindo

As hemorragias são consequências de um rompimento, cisão ou dilaceração dos vasos sanguíneos e podem ser internas ou externas. Nesses casos, ao realizar os Primeiros Socorros, uma proteção para as mãos é indispensável.

As convulsões são contrações musculares generalizadas, violentas ou não, com possível perda da consciência. Nos casos de desmaios as vítimas também ficam inconscientes.

Quando ocorre com a vítima, simultaneamente, parada cardíaca e respiratória há necessidade de se fazer respiração artificial (boca a boca) e a massagem cardíaca ao mesmo tempo.

Em caso de queimadura não se deve passar nenhum tipo de produto (pastas, pomadas, ovo, óleo ou manteiga). Use apenas água.

A fratura é a quebra de um osso, podendo ser aparente ou interna. Em caso de fratura exposta, cubra o local com um pano limpo ou gaze e procure socorro.

Glossário

Broncoaspiração: condição em que alimentos, líquidos, saliva ou vômito são aspirados para as vias aéreas.

Reação vasovagal: é uma síncope (desmaio) relacionada à ativação inapropriada pelo nervo vago.

Traqueia: No homem, e nos animais que têm pulmões, canal que conduz o ar aos pulmões.

Vias aéreas: constitui-se de nariz, fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões.



Atividades

1) As convulsões são contrações musculares generalizadas, violentas ou não, sempre acompanhadas da perda da consciência.

() Certo () Errado

2) A _____ é o sangramento de estruturas superficiais e, normalmente, pode ser contida com compressão direta sobre o ferimento, com a elevação do membro afetado e a compressão de pontos arteriais.

- a. () hemorragia externa
- b. () hemorragia interna
- c. () fratura externa (exposta)
- d. () fratura interna

3) As fraturas fechadas (internas), apesar do choque, deixam a pele intacta. Já as fraturas externas (expostas) ocorrem quando o osso fere e atravessa a pele.

() Certo () Errado

4) Em caso de queimadura, não se recomenda:

- a. () Manter as bolhas intactas.
- b. () Manter a pele morta nem as bolhas.
- c. () Manter a roupa. Retirar qualquer peça imediatamente.
- d. () Passar pasta de dente nem manteiga.

Referências

ABRAMET. **Noções de primeiros socorros no trânsito**. São Paulo: Casa Brasileira do Livro, 2005.

APTOS CURSOS & SERVIÇOS. **Prevenção de Acidentes no Trânsito e Direção Defensiva** – Primeiros Socorros. Brasília, 2000.

BRASIL. **Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Rio de Janeiro, 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 24 out. 2015.

SILVA, A. K.; FERNANDES, A. **Tecnologia de Prevenção e Primeiros Socorros ao Trabalhador Acidentado**. São Paulo: AB, 2012.

VARELLA, D.; JARDIM, E. C. **Primeiros Socorros** – Um Guia Prático. São Paulo: Claro Enigma, 2011.

Gabarito

	Questão 1	Questão 2	Questão 3	Questão 4
Unidade 1	D	C	B	V - F - V - F
Unidade 2	E	A	C	D



EaD ***SEST SENAT***